

1. איזו מחלת מסתמים תגרום לדלף של דם מחדר שמאל
Mitral Regurgitation +
2. סמן את התרופה הגורמת לחסימה של פעילות פראסימפטטית
+אטרופין
3. מה יקרה ל CPP (Cerebral Perfusion Pressure) של אדם לאחר ירידה חדה בלחץ הדם?
+ ה CPP ירד. $CPP = MAP - ICP$
4. מהו DOPE
+ ראשי תיבות שמטרתן להעריך קושי בניהול נתיב אויר
5. לאיזו משפחה שייכת התרופה Amiodaron?
+ חסמי תעלות אשלגן
6. סיבת המוות במקרה של פנאומותרקס היא :
+ הלם מחוסר החזר ורידי
7. מהי השאלה החשובה ביותר באנמנזה אצל מטופל עם חשד ל Stroke?
+ מתי החלו הסימנים
8. הגעת למטופל כבן 30 בקניון. עוברי אורח הזמינו אמבולנס על חוסר הכרה. המטופל מציג את הסימנים הבאים :
A- מחוסר הכרה ללא תגובה לכאב. אובדן שליטה על סוגרים (שתן בלבד).
B – טכיפנאיי, האזנה נקיה, סאטורציה 92% באויר החדר. עם חמצן 98%.
C- דופק נימוש, סדיר, קצב 120 לחץ דם 100/60
D-סטיית מבט בשתי העיניים.
+ ערכי סוכר 80%
+ פרכוס
9. חולה באסיסטולה קיבל מנה ראשונה של אדרנלין ללא תגובה. הפארמדיק רוצה לתת מנה שניה של אדרנלין לאחר 5 דקות. באיזה מינון התרופה?
+ 1mg.
10. באיזו פגיעת ראש יש לצפות ליציאת נוזל CSF מהאף/אזניים?
+ שבר בסיס הגולגולת
11. בלשב בו שוק היפולמי מפוצה, מתקיימים התהליכים הבאים :
+ ל.ד נשמר , הדופק עולה.
12. נקראת לתת טיפול לחייל בן 19 המשרת ביחידה מיוחדת שהתמוטט לאחר מסע אלונקות ארוך.
בבדיקתו : מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה.
כיצד יש לנהוג במקרה כזה?
+ לוודא בטיחות, הזמנת סיוע, ביצוע עיסויים, חיבור לAED, הנשמות באמצעות מפוח אמבו. קירור חיצוני תוך כדי פעולות החיאה.
13. מה הגורם העיקרי להיפוגליקמיה בחולה סוכרתי?
+ הזרקת אינסולין במינון גבוה.

14. תוך כדי הטיפול שלך בחולה לב עם כאבים בחזה, מאבד את ההכרה באופן פתאומי ובמוניטור מופיע VF. מהי הפעולה הנדרשת.
+ התחלת עיסויים באופן מיידי ומתן שוק חשמלי בהקדם.
15. באיזה מהכוויות הבאות יש חשיבות לחבר מוניטור בסקר הראשוני?
+ כוויות חשמל
16. איזה מהתרופות הבאות לא מיועדת לטיפול בהתקף אסטמה?
+ אספירין
17. אספירין נחשבת כיום כתרופה חשובה לטיפול בחולי לב בשלב החרף של האוטם.
מדוע?
+ אסיפרין מונע הצמדות של טסיות דם.
18. מהי ההנחיה בפרוטוקול ROSC במידה וניתן אמיודורון בהחייאה?
+ יש לתת מנת אחזקה של אמיודורון.
19. מי מהבאים אחראי על ויסות חום הגוף אצל בני האדם?
+ תלמוס
20. מה מאפיין את הפגיעה העיקרית שיוצרת אמפיזמה אצל חולי COPD?
+ הרס קירות הנאדיות
21. איזה מהבאים הוא סימן מובהק להתפתחות חזה אויר בלחץ?
+ גודש בורידי הצוואר.
22. למה תגרום הפעלה של תאי MAST באנאפילקסיס?
+ להפעלת היסטמין
23. מהו המנגנון של סכרת סוג 2?
+ חוסר יכולת של הגוף לקלוט אינסולין.
24. המשפט הנכון לגבי היפוגליקמיה הוא?
+ ההתפתחות של היפוגליקמיה היא מהירה.
25. הוזעקתם לאירוע של מטופל מחוסר הכרה בחממה. בהגעתכם הנכם מבחינים בגבר שוכב, מחוסר הכרה, פרכוס טוני-קלוני. לאחר שהפרכוס הסתיים, בבדיקה הנכם מבחינים בריוור, ברדיקארדיה, אישונים מכווצים. מבין הבאים במה תחשוד?
+ הרעלת אופייטים
26. לאיזה אות ב PQRST-A "שייכת השאלה" בסולם של 1 עד 10, כאשר 10 הוא הכאב העוצמתי ביותר, "כמה כואב לך עכשיו"?
+ השאלה שייכת ל S.
27. הנך בודק נפגע אשר "צנח" לו מקומה שלישית. הנפגע מחוסר הכרה, נשימות 6 בדקה, מחרחרות, כניסת אוויר פחותה בצד ימין. דופק 130 לדקה חלש וחוטי! דמם מהאף ומהאוזניים, והמטומות משקפיים. מרחק פינוי לביה"ח 3 דקות. מהי פעולת הראשונה?
+ אבטחת נתיב אויר AW

28. אדם לוקח מזה כחמש שנים תרופה ממשפחת חוסמי בטא. בתקופה האחרונה הוא החל לסבול מדופק מואץ ולחץ דם גבוה למרות שנוטל את התרופה כרגיל. מה יכולה להיות הסיבה לכך?
+ הוא החל לפתח סבילות לתרופה.

29. מה מהבאים הוא סיבוך של התחשמלות?
+ הפרעות קצב

30. איזו מן התרופות הבאות תינתן במינון חד פעמי ואין לחזור עליה במהלך הטיפול?
Etomidate+

31. הגעתם למטופל שבמסמך הרפואי מופיעה האבחנה Cor Pulmonale איזו מחלה מהבאות יכולה להיות הסיבה לכך?
COPD +

32. כיצד נקרא תהליך ייצור גלוקוז ע"י פירוק שומנים בגוף?
+ גלוקוניאוגנזה

33. כמה גרם גלוקוז יש באמפולה של 50% - 50cc?
+ 25 גרם

34. מה מהבאים יהווה סימן לטמפונדה לבבית בפגיעת חזה?
+ גודש ורידי צוואר

35. מבחינה כרונולוגית מהו סדר הפעולות במנגנון renin angiotensin ?
+ רנין מופרש מה juxatlomerular apparatus
שלב הבא הופך אנגיוטנסינוגן ל אנגיונסטין 1.
השלב הבא אנגיונסטין 1 הופך באמצעות ACE לאנגיונסטין 2

36. הסכנה העיקרית בשטח לנפגע כוויות 15% בפנים
+ בעיה בנתיב אויר

37. מהו המנגנון המוביל להנתעלפות?
+ ירידה זמנית בזרימת הדם למוח?

38. מה ניתן לצפות בדימום שמקורו דליות בוושט?
+ הקאות דם טרי

39. לחץ הדם הוא ערך הנמדד ממכפלה של 3 גורמים :
+ קוטר(טונוס) כלי הדם, תפוקת הלב (נפח פעימה+קצב הלב), נפח הדם.

40. פענח את האק"ג הבא :
Inferior Lateral +

41. הקינמטיקה בלבד בטרומה יכולה לגרום לי להחליט שהפצוע קשה
+ נכון

42. איזו מן התרופות הבאות יוצרת סדציה ושיכוך כאב יחד?
+ קטמין

43. הגעת לתאונת דרכים הנפגע בהכרה אך באי שקט. דופק 135 חלש, נשיות 3 בדקה, לחץ דם 70/50 הנפגע חיוור ומזיע אך ללא סימנים חיצוניים. במה תחשוד?
+ פגיעת בטן.

44. איזה מהגירויים הבאים הוא המשפיע העיקרי על מרכזי הנשימה במוח אצל אדם בריא?
+ עליה ב PCO_2

42. אשה בהריון אמורה ללדת ב
+ שבוע 37-42.

43. בטמפונדה לבבית מצטבר דם :
+ בין קרומי הלב

44. באיזה מן המקרים הבאים יש להמנע ממתן אדנוזין :
+ כאשר ידוע כי החולה סובל מ WPW.

45. מה מהבאים נכון עבור STROKE המורגי?
+ פרוגנוזה גרועה יותר מאשר stroke איסכמי.

46. מהו הסיכון העיקרי בתסמונת מדור?
+ איסכמיה של הגפה.

47. מדוע נצפה לראות חזה חביתי בקרב חולי COPD?
+ עקב כליאת האוויר הכרונית בנאדיות.

48. פגיעת ראש המאופיינת בחוסר הכרה מידית לפגיעה ולאחר מכן תקופה של ערנות שלאחריה ירידה במצב ההכרה, מאפיינת בעיקר?
+ דם אפידורלי

49. האורטה (AORTA) הוא כלי דם :
+ עורקי- המוציא דם מחדר שמאל

50. כיצד ניתן לכוון את התחושה שחווים חולי אפילפסיה טרם הפירכוס?
+ אאורה

51. הגעת לחולה עם הפרעת קצב המופיעה מטה (פרפור פרוזדורים). החולה סובל מההפרעה במשך 3 ימים. מהו הסיכון הגדול ביותר במידה וינסה להפוך את החולה לקצב סינוס בביתו?
+ החולה עלול לשלוח תסחיף למוח